

1. Introducción y relevancia clínica

La **neuronitis vestibular** (también llamada **neuritis vestibular**) es una **inflamación del nervio vestibular** que provoca un cuadro agudo de **vértigo intenso y prolongado, sin compromiso auditivo**, producto de una disfunción súbita del sistema vestibular periférico unilateral.

Representa una de las principales causas de **vértigo periférico agudo no posicional**, junto con la enfermedad de Ménière y el vértigo postraumático.

Relevancia clínica

- Es responsable de aproximadamente **10–15% de los casos de vértigo periférico**.
- Suele afectar a **adultos jóvenes y de mediana edad (30–50 años)**.
- La mayoría de los pacientes se recupera completamente en semanas, pero algunos presentan **inestabilidad residual o vértigo crónico compensado**.
- Es crucial **distinguirlo de causas centrales** (infarto cerebeloso, AIT vertebrobasilar), ya que su presentación inicial puede simular un accidente vascular.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional

El **nervio vestibular**, rama del VIII par craneal, transmite información del laberinto al tronco encefálico.

Contiene dos divisiones:

- **Superior:** conduce señales de los canales semicirculares anterior y lateral, y del utrículo.
- **Inferior:** del canal posterior y del sáculo.

2.2 Mecanismo fisiopatológico

La **neuronitis vestibular** corresponde a una **disfunción inflamatoria o viral** del nervio vestibular, con alteración del impulso vestibular unilateral.

- Se asocia frecuentemente a una **infección viral respiratoria previa (1–2 semanas antes)**.
- En la mayoría de los casos, el agente probable es **virus herpes simple tipo 1 (HSV-1)** latente en el ganglio vestibular de Scarpa.
- La inflamación produce **bloqueo de la conducción** en las fibras vestibulares, generando **asimetría del tono vestibular** entre ambos lados → vértigo rotatorio.

2.3 Compensación vestibular

Con el tiempo, el sistema nervioso central **compensa la pérdida unilateral** mediante plasticidad neuronal del cerebelo y tronco encefálico, lo que permite recuperar el equilibrio.

Sin embargo, esta compensación se retrasa si el paciente **permanece inmóvil o usa vestibulosupresores por tiempo prolongado**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Cuadro clínico típico

Manifestación	Descripción
Vértigo intenso y prolongado	De inicio súbito, dura horas a días, empeora con movimientos cefálicos.
Náuseas, vómitos e inestabilidad	Muy frecuentes, pueden requerir tratamiento sintomático.
Sin hipoacusia ni tinnitus	Diferencia clave con enfermedad de Ménière o laberintitis.

Desequilibrio residual	Persiste días o semanas, especialmente al girar la cabeza.
Síntomas vegetativos	Palidez, sudoración, taquicardia, ansiedad.

3.2 Examen físico

Paciente: acostado, evita mover la cabeza, con nistagmo espontáneo.

Signo	Descripción
Nistagmo espontáneo	Horizontal o rotatorio, hacia el lado sano; aumenta con la mirada en esa dirección.
Test de impulso cefálico (Head Impulse Test)	Sacada correctiva al girar la cabeza hacia el lado afectado.
Romberg	Desviación hacia el lado afectado.
Marcha en estrella de Unterberger	Giro hacia el lado lesionado al marchar con ojos cerrados.

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencias clave
Laberintitis	Igual vértigo, pero con hipoacusia y tinnitus.
Enfermedad de Ménière	Crisis de vértigo con hipoacusia fluctuante y plenitud auricular.

Vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB)	Episodios breves, desencadenados por posición, no prolongados.
Accidente cerebrovascular (ACV) vertebrobasilar o cerebeloso	Vértigo persistente, signos neurológicos focales, disartria, diplopía o ataxia.
Migraña vestibular	Historia de migraña, vértigo recurrente, sin hipoacusia.
☐ Regla de oro: el vértigo periférico (como la neuronitis vestibular) nunca produce síntomas neurológicos centrales (debilidad, diplopía, disartria).	

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

El diagnóstico de **neuronitis vestibular es clínico** y se basa en:

1. Vértigo rotatorio intenso y prolongado (>24 h).
2. Ausencia de síntomas auditivos.
3. Nistagmo unidireccional horizontal o rotatorio.
4. Test de impulso cefálico anormal hacia el oído afectado.
5. Exclusión de causas centrales (ACV).

4.2 Exámenes complementarios (solo en casos atípicos)

Examen	Utilidad
RM con gadolinio de tronco y ángulo pontocerebeloso	Si hay síntomas neurológicos o dudas diagnósticas.

Audiometría	Para confirmar ausencia de compromiso auditivo.
Pruebas vestibulares (VNG, vHIT)	Documentan hipofunción unilateral.
Hemograma / serologías virales	No rutinarias; solo si sospecha etiología infecciosa sistémica.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento tiene tres objetivos:

1. **Control de los síntomas agudos.**
2. **Favorecer compensación vestibular.**
3. **Prevenir complicaciones.**

5.1 Fase aguda (primeras 48–72 horas)

Medida	Fármaco / Dosis	Objetivo
Corticoides	Prednisona 1 mg/kg/día por 10 días, con descenso progresivo.	Disminuye inflamación nerviosa y mejora recuperación vestibular.
Antieméticos	Dimenhidrinato 50 mg VO c/8h o metoclopramida 10 mg IV.	Control de vómitos.
Benzodiacepinas	Diazepam 5 mg VO c/12h o clonazepam 0,5 mg c/12h.	Sedante vestibular y ansiolítico.

Hidratación y reposo relativo.

Favorece recuperación y compensación inicial.

❑ **Importante:** Los **vestibulosupresores** deben **suspenderse a los pocos días**, ya que su uso prolongado **retarda la compensación vestibular**.

5.2 Fase de recuperación

Inicia tras 3–5 días, cuando el vértigo intenso cede.

Rehabilitación vestibular precoz (clave del manejo):

- Ejercicios de habituación y reeducación postural (Brandt-Daroff, Cawthorne-Cooksey).
- Estimular movimientos cefálicos suaves progresivos.
- Promover marcha independiente.

Evitar reposo prolongado.

El movimiento estimula la plasticidad central y acelera la compensación.

5.3 Casos refractarios o severos

- Corticoides intratimpánicos (dexametasona) en casos con mala evolución.
 - Antivirales (aciclovir) solo si hay sospecha fuerte de reactivación de HSV, aunque la evidencia es débil.
 - Rehabilitación vestibular intensiva en cuadros prolongados (>3 semanas).
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación

Descripción

Desequilibrio residual

Persiste por semanas, mejora con rehabilitación.

Vértigo postural secundario (VPPB) Puede presentarse semanas después.

Ansiedad y fobias postvértigo

Miedo a recaídas o movimiento.

Compensación incompleta

En ancianos o sedentarios.

Pronóstico:

- **Excelente en la mayoría de los casos.**
- 90% mejora en 4–6 semanas.
- Vértigo crónico o recidivante es infrecuente.
- Recurrencia <10%.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Vértigo prolongado (>24 h) + sin hipoacusia = neuronitis vestibular.**
 2. El **test de impulso cefálico positivo** es diagnóstico.
 3. El **nistagmo horizontal unidireccional** se dirige al lado sano.
 4. **Corticoides sistémicos** mejoran la recuperación vestibular.
 5. Los **vestibulosupresores deben suspenderse precozmente.**
 6. La **rehabilitación vestibular temprana** acelera la compensación y previene secuelas.
-

Errores comunes

- Confundir con **laberintitis** (que sí tiene hipoacusia).
 - Mantener diazepam o dimenhidrinato por semanas.
 - No indicar ejercicios vestibulares.
 - No descartar ACV en pacientes mayores con factores de riesgo vascular.
 - Diagnosticar “vértigo posicional” sin realizar maniobras diagnósticas.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **neuronitis vestibular** es una **inflamación aguda del nervio vestibular**, generalmente de origen viral.
2. Produce **vértigo prolongado (horas o días)**, sin hipoacusia ni tinnitus.
3. El diagnóstico es **clínico**, con **test de impulso cefálico positivo** y **nistagmo unidireccional**.
4. El **tratamiento inicial** incluye **corticoides**, **antieméticos** y **reposo breve**.
5. Se debe **suspender pronto los vestibulosupresores** y comenzar **rehabilitación vestibular precoz**.
6. La recuperación suele ser **completa en 4–6 semanas**.
7. Recurrencias o síntomas residuales deben diferenciarse de VPPB o causas centrales.